DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE
INTEGRATO SALUTE MENTALE
DIPENDENZE PATOLOGICHE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

REPORT D'ATTIVITÀ

Dipartimento Assistenziale Integrato

Salute Mentale

Dipendenze Patologiche

2024

A cura di

UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO E OSSERVATORIO SULLE DIPENDENZE

PRESENTAZIONE

Con piacere presento il Report 2024 delle attività del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DAI-SMDP). Si tratta di uno strumento agile e utile per comprendere il quadro epidemiologico dei disturbi mentali e delle dipendenze patologiche nella provincia di Parma. La cultura dei dati, la loro analisi è requisito per potere analizzare qualità e appropriatezza dei processi e degli esiti nonché per la programmazione, la formazione e la ricerca.

Dal 1978 il Servizio Sanitario pubblico e universale, frutto di un grande impegno collettivo, è essenziale per assicurare il diritto alla salute mediante la prevenzione, la terapia e la riabilitazione. Ma ciò non è sufficiente in quanto la salute delle persone e il benessere di comunità si realizzano non solo con le attività sanitarie, ma anche mediante adeguati stili di vita e azioni sociali, educative, produttive, culturali e sportive ed una cura dell'ambiente e della sua qualità. L'attenzione alla salute, compresa quella mentale, deve essere presente in tutte le politiche.

Il sistema di welfare pubblico e universalistico ha bisogno di essere sostenuto dall'apporto di tutti i cittadini e da adeguate risorse economiche. Al contempo, deve essere fatto ogni sforzo per migliorare la qualità delle cure, innovare il sistema e migliorarne l'efficacia ed efficienza anche coinvolgendo e educando i cittadini per un suo corretto utilizzo.

L'obiettivo del mio mandato è portare a compimento il processo di unificazione delle Aziende Sanitarie di Parma che costituisce una grande occasione per qualificare i percorsi di cura e le reti cliniche.

A questo proposito, il DAI-SMDP rappresenta un valido esempio di come si possano unire insieme le componenti ospedaliere, territoriali, universitarie, privato sociale e imprenditoriale. Ha una lunga tradizione basata sulle esperienze di Franco Basaglia e Mario Tommasini e costituisce un presidio fondamentale per la salute dei cittadini e il benessere delle comunità.

Ringrazio vivamente i professionisti del Dipartimento, di cui ho potuto apprezzare la competenza, la sensibilità, la motivazione e la propensione all'innovazione, per il loro lavoro quotidiano con il quale contribuiscono in modo determinante alla valorizzazione e allo sviluppo del sistema di welfare.

Anselmo Campagna

Commissario straordinario Azienda Usl di Parma

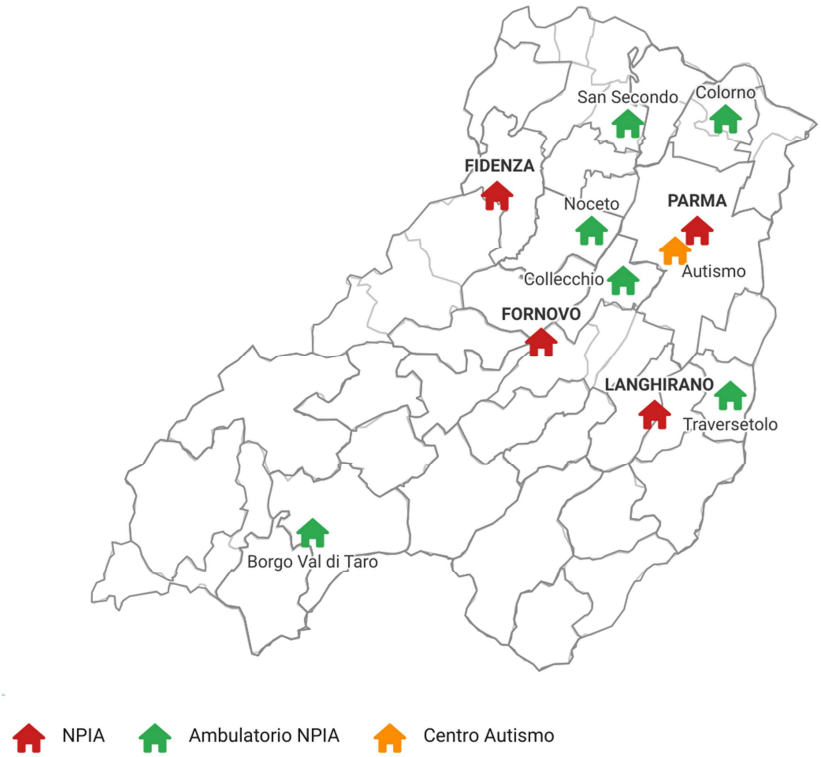
Direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

SOMMARIO

PRESENTAZIONE **1**
I SERVIZI DEL DAISMDP **3**
GLI ACCESSI AL DAISMDP: UNA PANORAMICA **6**
NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (NPIA) **8**
SEGMENTO 0-3 ANNI 9
RESIDENZA INTENSIVA E POST ACUZIE PER MINORI SAN POLO 10
SALUTE MENTALE ADULTI (SMA) **11**
SERVIZI PSICHIATRICI OSPEDALIERI 13
DIPENDENZE PATOLOGICHE (DP) **15**
LE DIPENDENZE PATOLOGICHE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PARMA 17
TABAGISMO 18
AMBULATORIO PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE (AMLDP) 18
UNITÀ DI STRADA (UDS) **20**
PROGRAMMI E PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI (PDTA) **23**
PDTA AUTISMO 23
PERCORSO TUTELA MINORI 24
ESORDI PSICOTICI 25
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE (DNA) 25
DISTURBI GRAVI DI PERSONALITÀ (DGP) 26
PERCORSI GIUDIZIARI 28
BUDGET DI SALUTE (BdS) 28
Gli incontri con il Comitato Utenti Familiari (CUF) **30**
Appendice **31**
NOTE CONCLUSIVE **32**

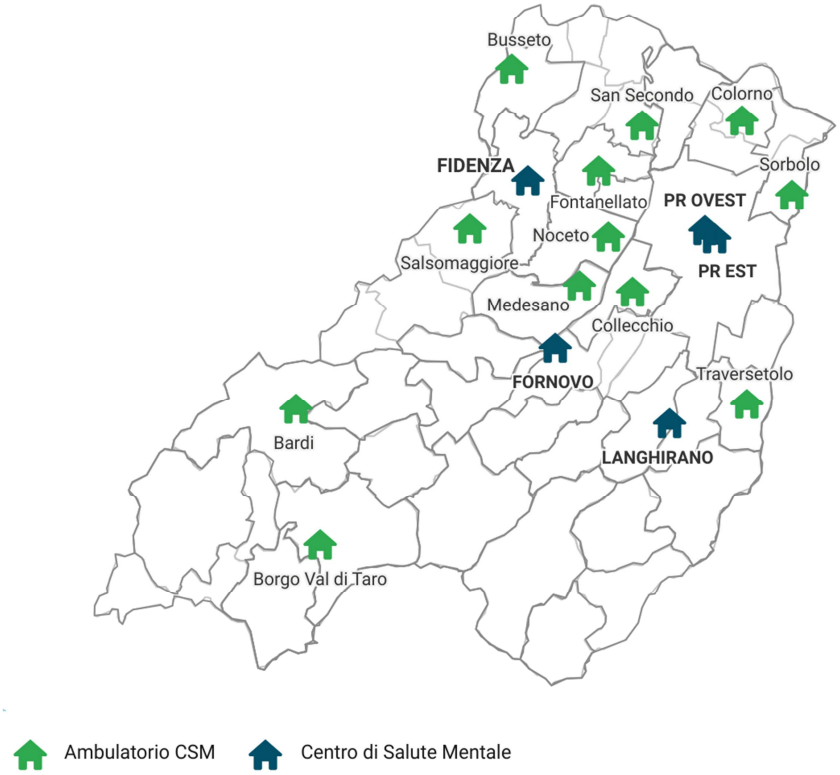
I SERVIZI DEL DAISMDP

La Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza (NPIA)



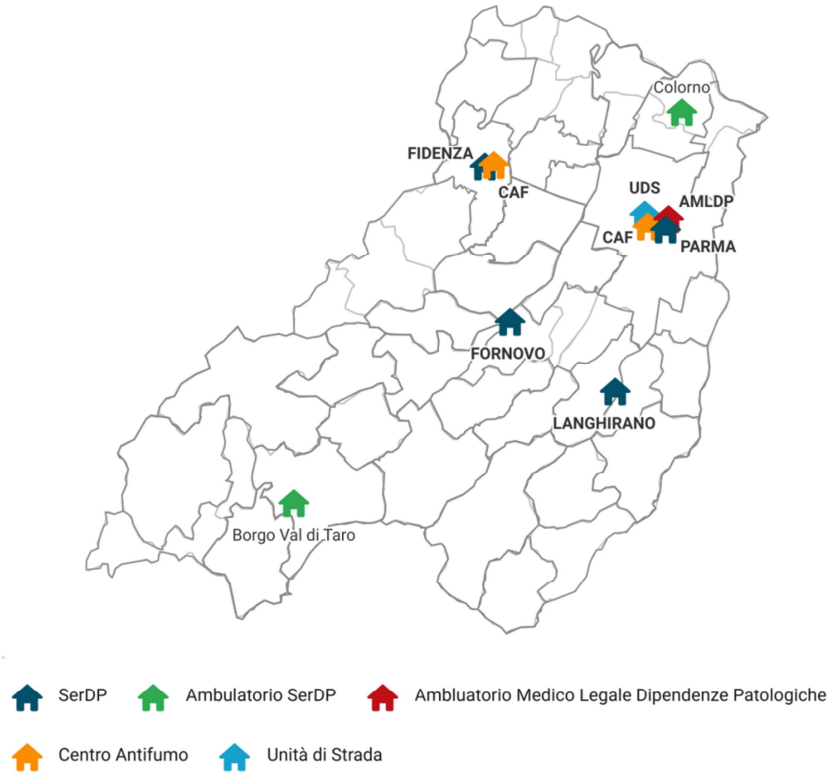
NPIA DI PARMA	*Viale Fratti 32/1A - Parma*
U.O. di Psichiatra e Psicologia Clinica dell'infanzia dell'adolescenza	*Viale Fratti 32/1A - Parma*
U.O. di Neurologia Funzionale e della Riabilitazione	*Viale Fratti 32/1A - Parma*
Integrazione Socio-Sanitaria per Minori	*Viale Fratti 32/1A - Parma*
Centro per la diagnosi, la cura e lo studio dei disturbi della comunicazione e della socializzazione (Autismo)	*Via Spezia 147 – Parma*
NPIA DI FIDENZA	*Via Don Tincati, 5 – Fidenza*
Ambulatorio NPIA di Noceto	*P.za C. Alberto Dalla Chiesa, 30 – Noceto*
Ambulatorio NPIA di San Secondo	*P.za Martiri della Libertà, 24 - San Secondo*
NPIA DI LANGHIRANO	*Via Roma, 42/1 – Langhirano*
Ambulatorio NPIA di Collecchio	*Via Berlinguer, 2 – Collecchio*
Ambulatorio NPIA di Traversetolo	*Via IV Novembre, 33 – Traversetolo*
NPIA DI FORNOVO DI TARO	*Via Solferino, 36 – Fornovo di Taro*
Ambulatorio NPIA di Borgotaro	*Via Benefattori, 12 - Borgo Val di Taro*

La Salute Mentale Adulti (SMA): i Centri di Salute Mentale (CSM)



CSM PARMA EST	*Largo Natale Palli, 1*
CSM PARMA OVEST	*Via Giorgio Vasari 13*
Ambulatorio CSM di Colorno	*Via Suor Maria 3 – Colorno*
Ambulatorio CSM di Sorbolo	*Via del Donatore 2 – Sorbolo*
CSM FIDENZA	*Via Berenini 153 – Fidenza*
Ambulatorio CSM di Salsomaggiore	*Via Roma 1, Salsomaggiore Terme*
Ambulatorio CSM di San Secondo	*Piazza Martiri libertà 1 - San Secondo*
Ambulatorio CSM di Busseto	*Via XXV Aprile 2 – Busseto*
Ambulatorio CSM di Noceto	*Via Dalla Chiesa 30 – Noceto*
Ambulatorio CSM di Fontanellato	*Via XXIV Maggio 16- Fontanellato*
CSM LANGHIRANO	*Via Roma 42/1- Langhirano*
Ambulatorio CSM di Collecchio	*Via Fratelli Rosselli 1- Collecchio*
Ambulatorio CSM di Traversetolo	*Via IV Novembre 33 – Traversetolo*
CSM FORNOVO DI TARO	*Via Solferino 37 – Fornovo di Taro*
Ambulatorio CSM di Borgotaro	*Via Benefattori 12, Borgo Val di Taro*
Ambulatorio CSM di Medesano	*Piazza Rastelli 2 – Medesano*
Ambulatorio CSM di Bardi	*Via Arandora Star 11, Bardi*

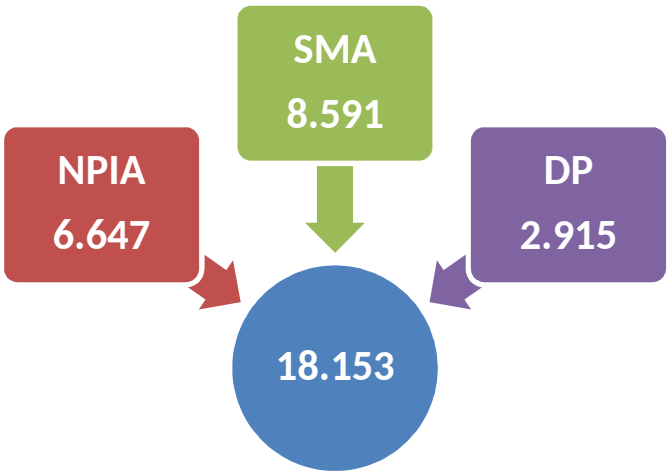
Servizi per le Dipendenze Patologiche (SerDP)



SERDP PARMA	*Strada dei Mercati 15/b – Parma*
Unità di Strada – Drop-In	*Strada dei Mercati 7 – Parma*
Centro Antifumo (CAF) - Parma	*Via Gaime Pintor, 1 – Parma*
Amb. Accertamenti Medico Legali (AMLDP)	*Via Vasari, 13/a – Parma*
Ambulatorio di Colorno	*Via Suor Maria 3 – Colorno*
Dipendenze Patologiche negli Istituti Penitenziari (	*Strada Burla, 59 – Parma*
SERDP FIDENZA	*Via don Tincati - Ospedale di Vaio Fidenza*
Centro Antifumo (CAF) - Fidenza	*Via don Tincati - Ospedale di Vaio Fidenza*
SERDP LANGHIRANO	*Via Roma 42/1 - Langhirano*
SERDP FORNOVO DI TARO	*Via Solferino 37 – Fornovo di Taro*
Ambulatorio SerDP Borgo val di Taro	*Via Benefattori 12, Borgo Val di Taro*

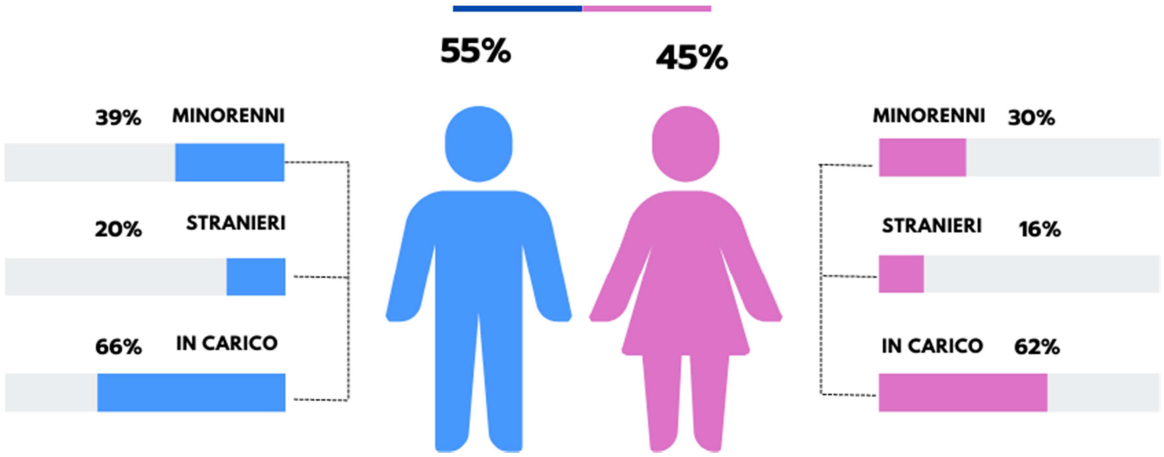
GLI ACCESSI AL DAISMDP: UNA PANORAMICA

In questa sezione vengono presentati i dati relativi agli accessi, calcolati come il numero di individui che hanno ricevuto almeno una prestazione nel 2024 da una delle unità operative del DAI-SMDP. Gli accessi rappresentano un'ampia ed eterogenea categoria che include sia i pazienti regolarmente in carico sia coloro che hanno usufruito dei servizi del Dipartimento per diversi motivi, che variano dalla semplice consulenza a questioni medico-legali.



In termini assoluti, nel 2024 le persone con almeno una prestazione erogata da un Servizio del DAISM-DP sono state complessivamente 17.634 (erano 17.081 nel 2023). Durante l'anno, alcune di queste possono avere avuto accesso a più aree: 161 persone hanno avuto un accesso nella NPIA e SMA, 14 nella NPIA e DP e 321 nella SMA e DP. Gli accessi delle singole aree sono rappresentati nella figura a fianco.

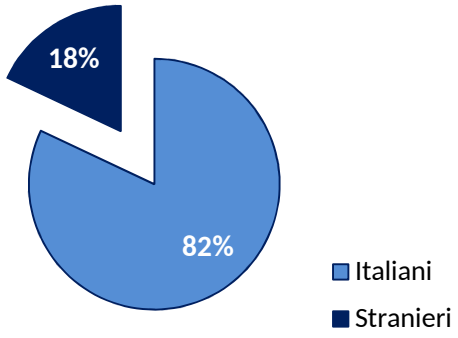
Analizzando la distribuzione per genere, si nota una prevalenza di maschi rispetto alle femmine. Tra i maschi, si osserva una percentuale più elevata di minorenni, di utenti stranieri e di soggetti presi in carico. La percentuale di donne che hanno avuto accesso al DAI-SMDP mostra notevoli variazioni tra le diverse aree disciplinari: il 39% nella NPIA, il 58% nella SMA e il 19% nelle DP.

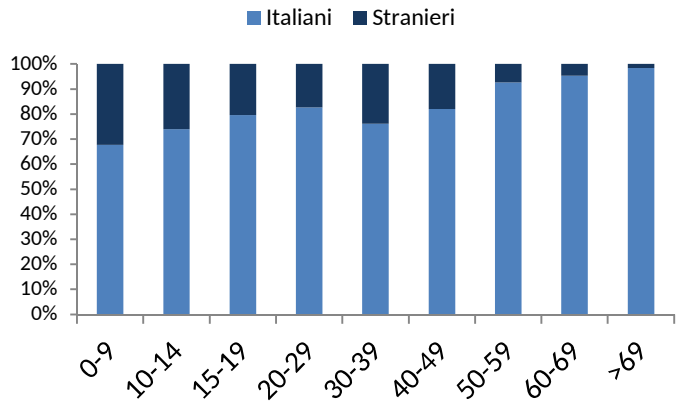


Età e genere degli accessi (2024)

Sesso	N	Media	Mediana	DS	Minimo	Massimo	Percentili	
							25°	75°
FEMMINA	7.953	38,0	38	23,7	0	99	15	58
MASCHIO	9.682	31,7	29	22,0	0	95	11	50

Nel 2024, il numero di persone di cittadinanza straniera che hanno avuto accesso ai servizi è stato 3.219 (18%), rispetto ai 3.214 (19%) registrati nel 2023. La maggioranza di questi individui sono maschi (61%), con un'età media di 23 anni, significativamente inferiore rispetto all'età media di 37 anni degli italiani. Analizzando gli accessi tra le diverse aree disciplinari, si nota una considerevole disomogeneità: i cittadini stranieri rappresentano il 28% degli accessi nella NPIA, 11% nella SMA e 18% nelle DP.





Nel grafico a fianco è rappresentata la distribuzione per fasce d'età e cittadinanza. Rispetto al 2023, si osserva un aumento dei minorenni stranieri che passano dal 25,5%, al 28,0%. Questo valore tende a diminuire con il progredire dell'età, diventando il 21% nel segmento 18-39 anni e il 9% oltre i 40 anni.

Nella tabella è riportata la distribuzione degli accessi, suddivisi per distretto sanitario del servizio che ha erogato le prestazioni. A fronte di un sostanziale incremento a livello dipartimentale, rispetto al 2023, gli accessi sono aumentati significativamente nel distretto di Parma, mentre sono diminuiti nei distretti di Fidenza e VTC. Nel distretto del Sud Est, gli accessi sono rimasti sostanzialmente stabili.

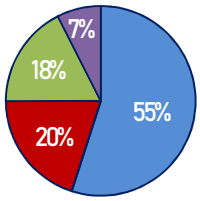
Complessivamente, nel 2024, i residenti di Parma e provincia che hanno avuto accesso al DAI-SMDP sono stati 17.106, rappresentando il 97% degli accessi totali e corrispondendo al 3,8% (era il 3,5% nel 2023) della popolazione residente. Relativamente alle aree disciplinari rispetto al 2023, si osserva un lieve aumento nel numero di accessi nella NPIA (+2%) e nella SMA (+10%) e una diminuzione nelle DP (-5%).

Distretto	NPIA		SMA		DP		Totale	
Socio Sanitario	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
PARMA	3.494	3.617	4.038	4.398	1.804	1974	9.336	9.989
FIDENZA	1.356	1.245	1.788	2.072	634	480	3.778	3.797
SUD EST	1.145	1.249	1.200	1.320	373	270	2.718	2.839
VTC	507	536	817	801	262	191	1.586	1.528
TOTALE	6.502	6.647	7.843	8.591	3.073	2.915	17.418	18.153

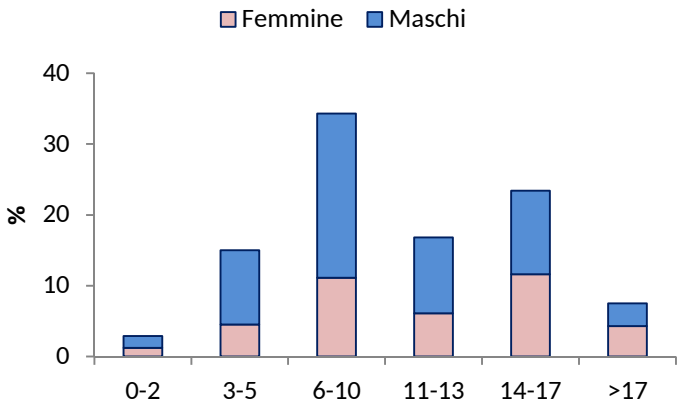
NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (NPIA)

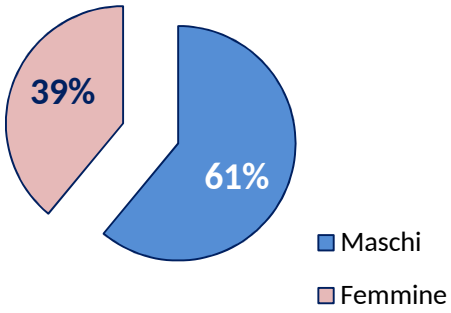
La seguente sezione considera i pazienti in carico, definiti come soggetti con progetti terapeutici gestiti dalla NPIA nel 2024. I dati registrano un aumento, tanto a livello complessivo quanto distrettuale, in particolare nel distretto di Parma. Circa il 6,1% dei minorenni residenti a Parma e provincia sono stati coinvolti in un progetto terapeutico presso la NPIA nell'anno in questione (era il 5,3% nel 2023).

DISTRETTO	2022	2023	2024
PARMA	1.955	2.255	2.558
FIDENZA	947	927	932
SUD EST	762	744	816
VTC	450	245	349
AUSL	**4.114**	**4.171**	**4.655**

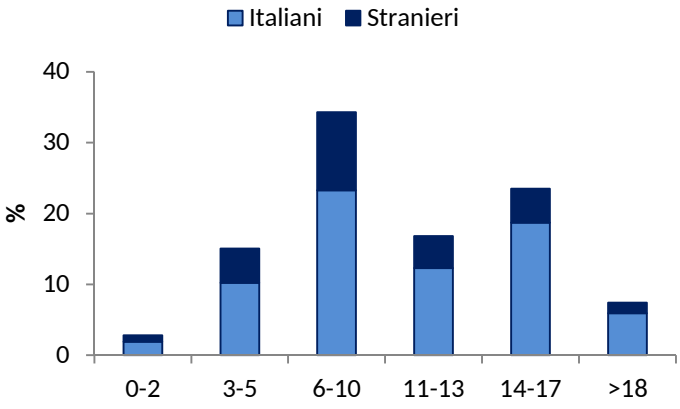


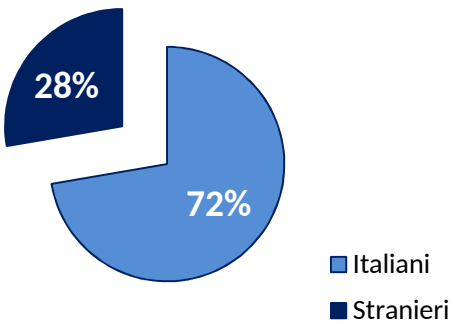
Tra i 4.655 pazienti in carico, il 61% è di sesso maschile (era il 67% nel 2023). L'equilibrio di genere si nota solo nella fascia adolescenziale (14-17 anni), mentre nella fascia d'età 6-10 anni, che rappresenta il segmento più numeroso per entrambi i sessi, i maschi sono circa il doppio delle femmine.





Il 28% dei pazienti seguiti dalla NPIA è di origine straniera, una proporzione sostanzialmente in linea con la presenza di minori stranieri residenti nel territorio, pari a circa il 30%. La distribuzione per età rispecchia quella dei pazienti italiani, con una prevalenza nella fascia 6-10 anni, corrispondente all'ingresso nella scuola primaria.





La tabella sottostante riporta la diagnosi principale registrata in cartella clinica per i pazienti in carico nel 2024 (4.655 diagnosi complessive). Sebbene un paziente possa presentare più diagnosi, ai fini dell'analisi è stata considerata unicamente quella prevalente. I disturbi evolutivi globali (autismo) rappresentano la condizione più diffusa (16%, vs 14% del 2023), seguito dai disturbi delle abilità scolastiche e del linguaggio, entrambi con una prevalenza del 15%. Tra i soggetti con diagnosi di autismo, il 20% è di sesso femminile mentre il 34% ha origine straniera. Nei disturbi nevrotici, dell'alimentazione e della personalità, le pazienti di sesso femminile risultano predominanti. I maschi sono invece più rappresentati nei disturbi del linguaggio e in quelli del comportamento e della regolazione emotiva.

TIPOLOGIA DIAGNOSI PRINCIPALE	N	%	Età media	FEMMINE (%)	STRANIERI (%)
DISTURBI EVOLUTIVI GLOBALI	748	16,1	8,7	19,3	34,0
DISTURBI DELLE ABILITA' SCOLASTICHE	693	14,9	11,7	45,6	26,1
DISTURBI DEL LINGUAGGIO	682	14,7	6,5	30,1	29,6
DIST. DEL COMPORTAMENTO E SFERA EMOZIONALE	561	12,1	11,4	23,0	21,7
RITARDO MENTALE	451	9,7	13,3	43,7	35,3
DISTURBI ORGANICI	439	9,4	8,3	45,8	28,5
DISTURBI NEVROTICI	279	6,0	14,4	61,6	18,6
ALTRI DISTURBI DELLO SVILUPPO	239	5,2	7,4	24,9	36,7
DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE	151	3,2	16,6	97,4	7,9
DISTURBI DELL'UMORE	71	1,5	15,8	63,4	18,3
SEGNI E SINTOMI NON CLASSIFICATI ALTROVE	64	1,4	11,0	46,9	26,6
DISTURBI DELLA PERSONALITÀ	52	1,1	16,9	88,5	13,5
SCHIZOFRENIA E DISTURBI DELIRANTI	46	1,0	16,6	45,7	28,3
CONDIZIONI ESTERNE/AMBIENTALI (*codici Z*)	172	3,7	10,6	53,5	24,4
In via di definizione	7	0,2	13.9	14,3	28,6

L'attività dedicata alla fascia d'età 0-3 è prevalentemente indirizzata a patologie di tipo neurologico, quali paralisi cerebrali infantili, patologie genetiche o cromosomiche ed esiti di prematuranza. Nella tabella sottostante sono riportate le diagnosi riferibili a questo specifico segmento.

SEGMENTO 0-3 ANNI

TIPOLOGIA DIAGNOSI	N	%	FEMMINE	STRANIERI
DISTURBI ORGANICI	119	41,9	50	36
DISTURBI EVOLUTIVI GLOBALI	57	20,1	17	25
DISTURBI DEL LINGUAGGIO	38	13,4	12	4
ALTRI DISTURBI DELLO SVILUPPO	33	11,6	4	11
RITARDO MENTALE	12	4,2	7	5
SEGNI E SINTOMI NON CLASSIFICATI ALTROVE	5	1,8	1	1
DIST. DEL COMPORTAMENTO E SFERA EMOZIONALE	2	0,7	1	1
CONDIZIONI ESTERNE/AMBIENTALI (*codici Z*)	18	6,3	10	4
Totale	284	100	102	87

RESIDENZA INTENSIVA E POST ACUZIE PER MINORI SAN POLO

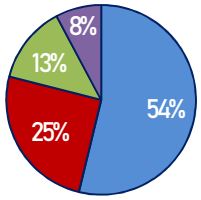
Nella RTI/RTP minori di S. Polo di Torrile, contrariamente agli anni precedenti, si è osservata una stabilità nel segmento RTI (Ricovero Terapeutico Intensivo) e una lieve diminuzione dei ricoveri in RTP (Ricovero Terapeutico Protratto). Per quanto riguarda le giornate di degenza, si è registrata un moderato incremento delle giornate in regime di ricovero intensivo e una stabilità delle giornate di degenza nel segmento protratto.

	2021	2022	2023	2024
Ricoveri Intensivi (RTI)	55	49	32	33
Ricoveri Post Acuzie (RTP)	31	28	21	17
Totale ricoveri	86	74	53	50
Giornate di degenza RTI	1.493	1.329	993	1.032
Giornate di degenza RTP	1.086	1.287	1.352	1.382

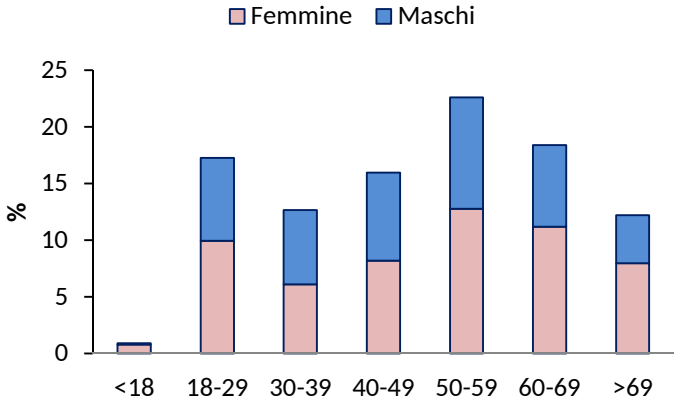
SALUTE MENTALE ADULTI (SMA)

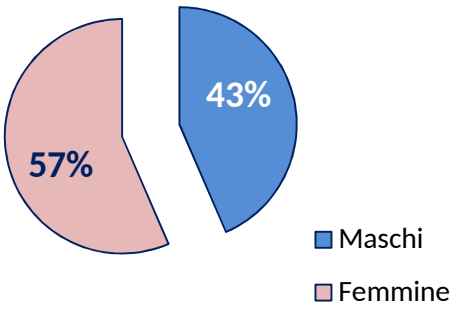
La seguente sezione analizza i pazienti in carico, definiti come soggetti con progetti terapeutici gestiti dai Centri di Salute Mentale (CSM) dei servizi di Salute Mentale Adulti (SMA) nel 2024. Rispetto all'anno precedente, emerge un rilevante aumento del numero di persone con progetto terapeutico (+18%). Dopo la diminuzione dell'anno scorso, attribuibile a prassi non ancora consolidate nell'inserimento dei dati nel nuovo sistema informativo CURE, i valori si stanno avvicinando a quelli rilevati nel 2022.

DISTRETTO	2022	2023	2024
PARMA	3.294	2.399	2.834
FIDENZA	1.218	1.158	1.329
SUD EST	941	538	697
VTC	661	378	411
AUSL	**6.114**	**4.473**	**5.271**

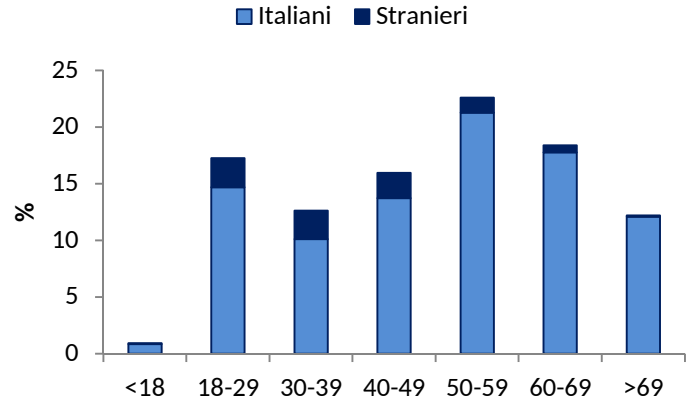


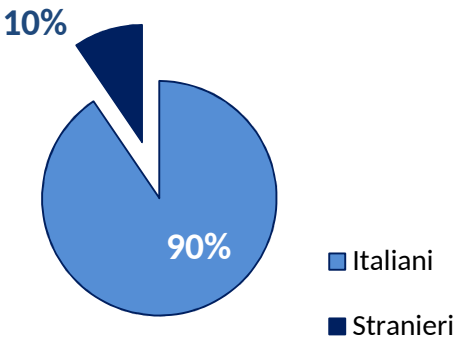
Nel 2024, circa l'1,4% (era 1,2% nel 2023) dei maggiorenni residenti a Parma e provincia ha preso parte a un progetto terapeutico presso i servizi della SMA. Tra i 5.271 pazienti in carico, il 57% è di sesso femminile. La prevalenza delle donne è maggiore in tutte le fasce d'età, ad eccezione della fascia 30-39 anni.





Il 9,5% dei pazienti seguiti dalla SMA è di origine straniera, una quota inferiore a quella dei maggiorenni stranieri residenti nel territorio (poco oltre il 14%). Questi pazienti si concentrano soprattutto nella fascia 18-49 anni e sono quasi assenti tra gli anziani.





Nel 2024, le diagnosi psichiatriche più frequenti sono: la schizofrenia e i disturbi correlati (24,5%), seguiti dal disturbo bipolare (17,1%) e dai disturbi della personalità (14%). Le donne risultano particolarmente rappresentate nei disturbi dell'alimentazione (94%) e nei disturbi depressivi (66,7%), mentre i maschi predominano in ambiti come il disturbo da uso di sostanze (68% maschi) e i disturbi evolutivi globali. L'età media varia sensibilmente tra le diagnosi: più bassa nei disturbi dell'alimentazione e nei disturbi comportamentali (intorno ai 25 anni), più alta nei disturbi organici, bipolari e depressivi (età media oltre i 53 anni). Nei pazienti stranieri, le diagnosi più frequenti sono la schizofrenia (12,6%, rispetto al 24,5% tra gli italiani), i disturbi psichici di natura organica (11,9%), i disturbi da uso di sostanze (11,1%) e i disturbi comportamentali ed emozionali (8,3%), con percentuali nettamente superiori a quelle rilevate nella popolazione italiana per le ultime due categorie. I dati suggeriscono una forte correlazione tra genere, età e cittadinanza con il tipo di disturbo, evidenziando la necessità di approcci terapeutici personalizzati e consapevoli delle differenze culturali.

DIAGNOSI PRIMARIA	2024	%	Età media	Femmine (%)	Stranieri (%)
SCHIZOFRENIA, DIST. SCHIZOTIPICO E DIST. DELIRANTI	1.290	24,5	50,7	44,0	12,6
DISTURBO BIPOLARE	902	17,1	57,1	59,4	9,4
DISTURBI DELLA PERSONALITÀ	738	14,0	44,7	63,4	5,8
DIST. NEVROTICI, LEGATI A STRESS E SOMATOFORMI	646	12,3	50,7	66,1	10,5
DISTURBI DEPRESSIVI	594	11,3	56,8	66,7	10,4
DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE	298	5,7	26,3	94,0	4,7
RITARDO MENTALE	214	4,1	46,3	46,7	6,1
DISTURBO DA USO DI SOSTANZE	153	2,9	45,3	32,0	11,1
DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO	143	2,7	45,3	49,7	3,5
DISTURBI EVOLUTIVI GLOBALI	92	1,7	26,2	23,9	6,5
DISTURBI PSICHICI DI NATURA ORGANICA	59	1,1	53,4	42,4	11,9
DIST. COMPORTAMENTALI ED EMOZIONALI	24	0,5	25,2	50,0	8,3
ALTRA DIAGNOSI	110	2,1	48,8	43,6	11,8
CONDIZIONI AMBIENTALI (CODICI Z)	8	0,2	39,1	37,5	12,5

Residenzialità Sanitaria Intensiva Territoriale	2022	2023	2024
Ricoveri	210	212	210
Giornate di degenza	7.140	8.955	7.402
Degenza media	34	42	35

Ricoveri Residenzialità Sanitaria Estensiva Territoriale (RTE)	2022	2023	2024
Ricoveri RTE - I° Maggio	9	10	16
Ricoveri RTE - Vigheffio	11	11	16
Ricoveri RTE - REGIA Casale di Mezzani	-	-	19
Totale RTE	**20**	**21**	**51**

Nel 2024 si è registrato un turnover del 36% nella rete sanitaria, in aumento rispetto al 26% del 2023. Il segmento della Residenzialità Intensiva ha rilevato l'8% di ricoveri oltre i 90 giorni, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale.

Nelle strutture a gestione esternalizzata (sanitarie e socio-sanitarie), il turnover complessivo è stato del 25,4%. In particolare, nel segmento socio-sanitario si è attestato al 24,3%, in lieve aumento rispetto al 22% del 2023.

Residenzialità Socio Sanitaria	2022	2023	2024
Inserimenti residenziali	99	109	111

SERVIZI PSICHIATRICI OSPEDALIERI

Nel corso del 2024 sono significativamente aumentati i ricoveri (+ 14,2%) e si stanno riavvicinando al periodo pre-Covid. Lieve l'incremento dei TSO e delle contenzioni meccaniche in SPDC (in tutto 7), tutte seguite da appositi audit. A tal proposito, sono stati strutturati percorsi formativi e attività specifiche finalizzate alla prevenzione dei TSO e al raggiungimento stabile dell'obiettivo di abolizione delle contenzioni, con l'intento di mantenere il reparto SPDC nel modello "*no restraint*".

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC)	2021	2022	2023	2024
Ricoveri	253	271	282	322
di cui da altre province/regioni/non residenti	24	40	21	42
TSO totali	90	96	101	106
TSO durante il ricovero	2	6	11	10
Contenzioni	2	4	5	7
Giornate di degenza totali	3.650	3.803	4.389	4.700
Degenza media (gg)	15	14	16	15
Presenza media giornaliera	10	10	12	13
Indice occupazione letti (%)	77	93	82	86

L'indice di reingresso a 8-30 giorni dopo un ricovero ospedaliero — unico indicatore previsto a livello nazionale per la SMA nei LEA — si attesta nel 2024 al 2,95%, con 16 reingressi su 542 ricoveri totali (di cui 10 in SPDC e 6 in SPOI), mantenendosi ben al di sotto dello standard nazionale fissato al 6,9%.

Il numero totale di consulenze effettuate è stato di 2.705 (in aumento rispetto alle 2.521 del 2023). Di queste, 925 sono state erogate ai reparti e 1.780 al pronto soccorso. In particolare, 95 consulenze hanno riguardato pazienti minori, registrando un incremento rispetto alle 65 dell'anno precedente.

In significativo incremento (+26%) i ricoveri in SPOI di Ausl e presso lo SPOI ospedale privato Maria Luigia (+14,7) che nel complesso mantiene un'attività in linea con quella dell'anno precedente.

Nel 2024 si rileva una diminuzione dei ricoveri di minori in ambito psichiatrico per adulti, con un totale di 23 ricoveri riferiti a 20 minori.

Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo AUSL PARMA	2021	2022	2023	2024
Ricoveri	165	164	249	315
Giornate di degenza	2.162	2.160	3.858	4.677
Degenza media	13,1	13,6	14,9	14,8

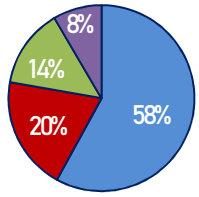
RICOVERI OSPEDALE MARIA LUIGIA	2022		2023		2024	
	N	GDM	N	GDM	N	GDM
SPOI	250	9,0	237	10,0	272	11,0
RTI	162	29,9	185	30,4	150	30,3
RTS Doppia Diagnosi	89	23,8	114	25,6	113	24,6
RTS Alcologia	46	26,5	51	26,5	45	30,0
Riabilitazione DCA	25	48,2	28	48,6	28	33,3
RTP	5	69,2	10	60,5	8	96,5
RTS Psicogeriatria	39	47,1	39	47,1	43	41,1

SPOI: Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo; RTI: Residenza Trattamento Intensivo; RTS: Residenza trattamento Specialistico; RTP: Residenza Trattamento Protratto; GDM: Giorni di degenza media.

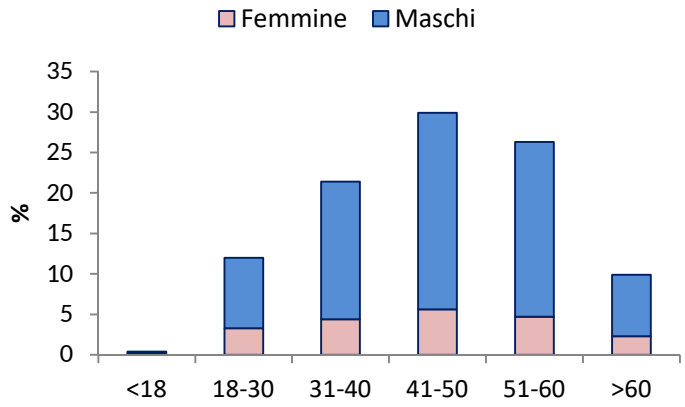
DIPENDENZE PATOLOGICHE (DP)

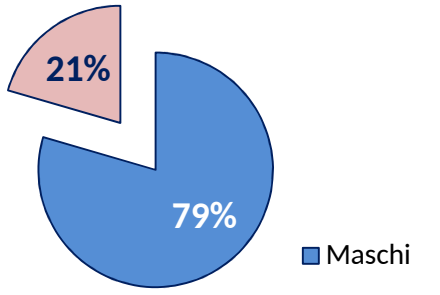
La seguente sezione riguarda le persone in carico con progetto terapeutico ai SerDP nel 2024. Rispetto all'anno precedente si rileva una diminuzione dei pazienti in tutti distretti. La variazione rilevata potrebbe riflettere l'impatto del progressivo allineamento dei SerDP alle nuove procedure di raccolta dati previste dal sistema informativo recentemente introdotto. Il SerDP del capoluogo ha in carico più della metà del totale dei soggetti in trattamento. Considerando la popolazione residente tra i 15 e i 64 anni, si registrano circa 6 pazienti in carico alle DP ogni 1.000 abitanti (0,6%).

DISTRETTO	2022	2023	2024
PARMA	1.097	1.071	980
FIDENZA	349	376	335
SUD EST	232	253	233
VTC	138	168	143
AUSL	1.816	1.868	1.691

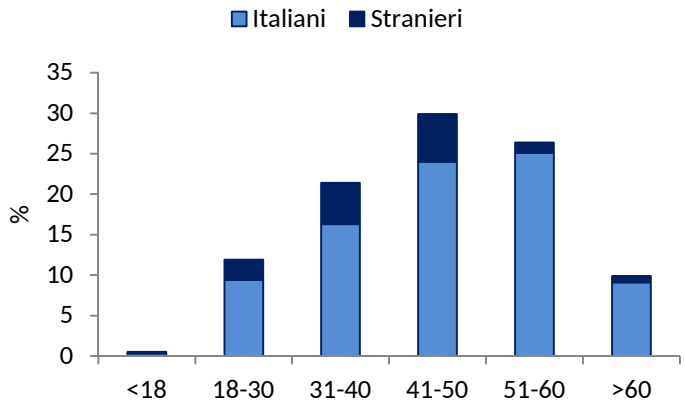


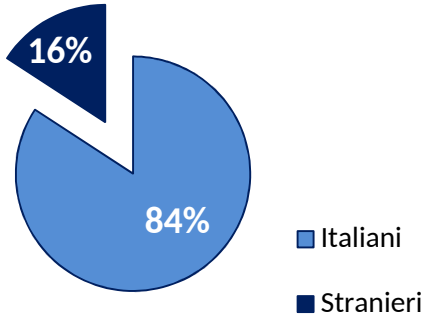
Le pazienti di sesso femminile in carico nelle DP nel 2024 sono state complessivamente poco più di un quinto del totale. Questo rapporto, storicamente consolidato, si manifesta in tutte le fasce d'età.





La percentuale di pazienti stranieri è passata dal 17% del 2023 al 16% del 2024, un valore in linea con la presenza degli stranieri residenti nel territorio di Parma nella fascia d'età tra 15 e 64 anni.

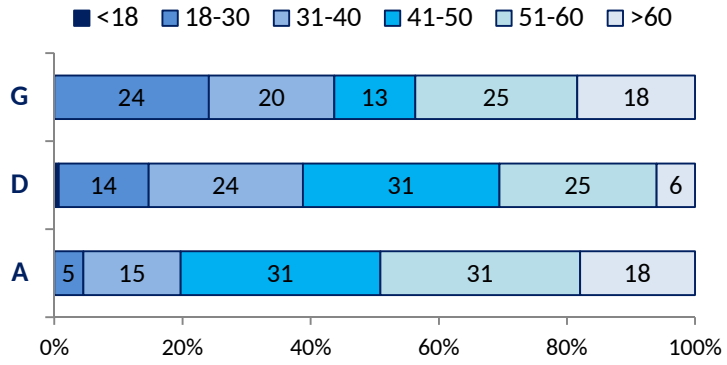




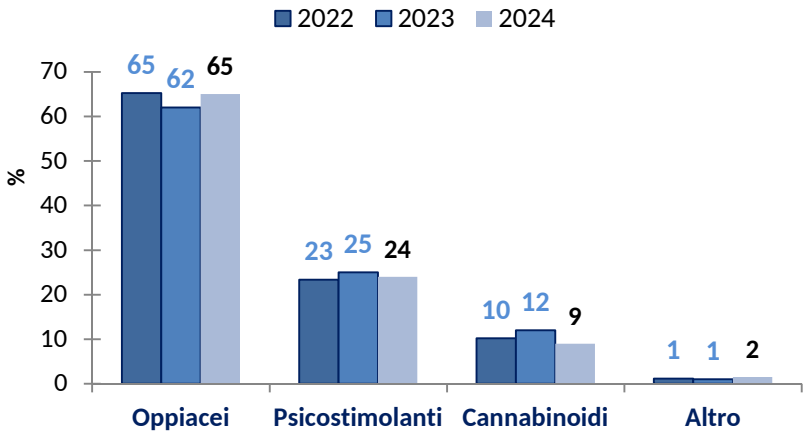
L'analisi dei dati per area problematica evidenzia, rispetto all'anno precedente, una lieve diminuzione complessiva del numero di pazienti nell'area Droghe e/o Farmaci, che passa da 1.330 a 1.142. Resta invece stabile l'area Alcol, mentre il numero di giocatori d'azzardo registra un lieve aumento, passando da 76 a 82. I pazienti con problemi di dipendenza da alcol si confermano quelli con la maggiore prevalenza di donne e cittadini stranieri, oltre a presentare un'età media più elevata.

AREA PROBLEMATICA	N	%	FEMMINE (%)	STRANIERI (%)	ETÀ MEDIA
ALCOL (A)	462	27,3	27,3	21,9	50,1
DROGHE E/O FARMACI (D)	1.142	67,5	18,2	13,8	43,3
GIOCO D'AZZARDO (G)	87	5,1	13,8	10,3	45,5

In linea con gli anni precedenti le aree problematiche mostrano differenze nella struttura per fasce d'età.



Le aree Alcol (A) e Gioco (G) mostrano la percentuale più alta di *over* 60, mentre i minorenni sono presenti solo nell'area Droghe (D). In quest'ultima, il 39% dei pazienti ha 40 anni o meno, percentuale che si attesta al 20% nell'area Alcol e sale dal 34% al 44% nell'area Gioco.



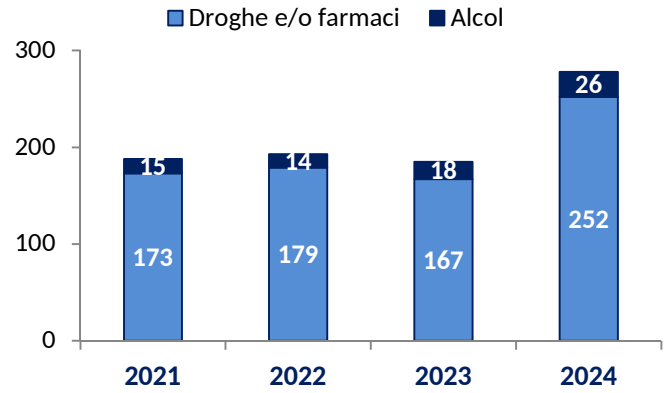
OPPIACEI	Età media: 46,2 Femmine:18,0% Stranieri: 14,1%
PSICOSTIMOLANTI	Età media: 41,2 Femmine:16,4% Stranieri:13,5%
CANNABINOIDI	Età media: 29,6 Femmine:20,0% Stranieri:13,3%

La classe degli psicostimolanti, che comprende cocaina e crack (forma fumabile della cocaina), rimane stabile rispetto all'anno precedente, confermando il suo rilevante impatto sui servizi di cura. I consumatori di psicostimolanti presentano bisogni clinico-assistenziali, manifestazioni comportamentali e pattern di consumo specifici che richiedono interventi terapeutici mirati. I programmi efficaci per il disturbo da uso di oppiacei non risultano trasferibili in modo diretto ai disturbi da uso di psicostimolanti, per i quali non esiste

attualmente un trattamento farmacologico *evidence-based*.

Nel 2024, i pazienti inseriti in comunità terapeutiche per interventi residenziali sanitari o sociosanitari sono stati complessivamente 115, di cui 102 (88,7%) accolti in strutture situate nel territorio della provincia di Parma e 13 (11,3%) in strutture fuori provincia. L'età media dei pazienti inseriti è di 40,5 anni (deviazione standard 12,2). Il 23,5% è di sesso femminile. Il 21% presenta problematiche alcol-correlate, mentre il restante 79% è affetto da un disturbo da uso di sostanze.

LE DIPENDENZE PATOLOGICHE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PARMA

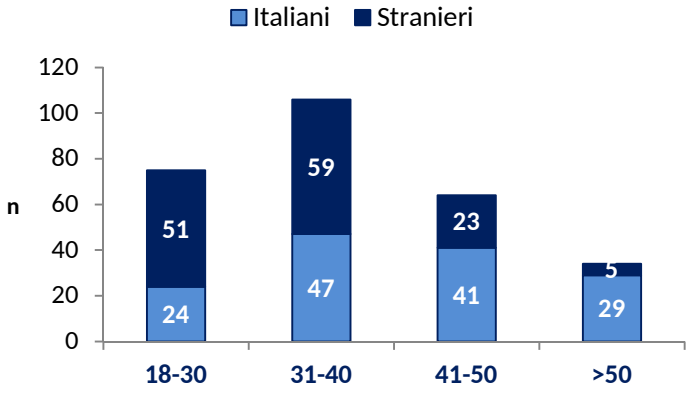


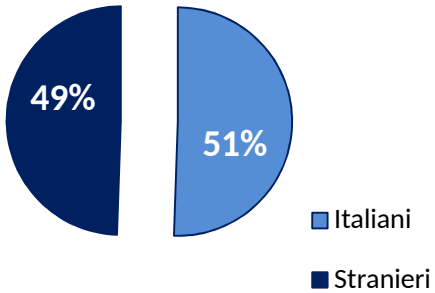
Il numero di pazienti in carcere con problemi da uso di sostanze registra un netto aumento, da 185 nel 2023 a 279 nel 2024.

La distribuzione tra le diverse aree resta sostanzialmente stabile, con la segnalazione di un caso legato al gioco d'azzardo.

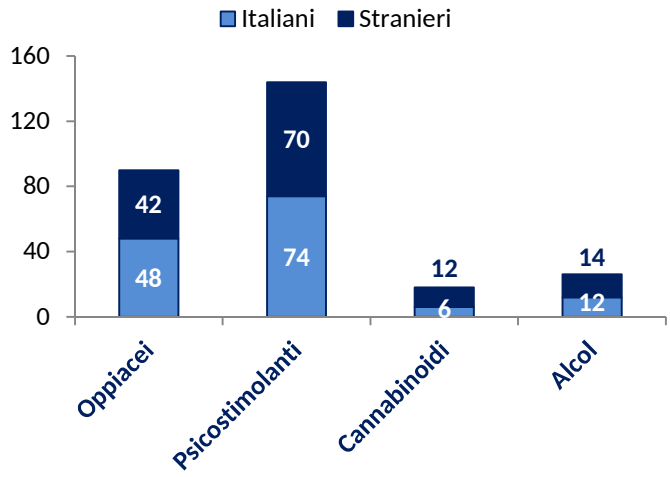
I pazienti con problematiche alcol-correlate rappresentano il 9,3% (10% nel 2023).

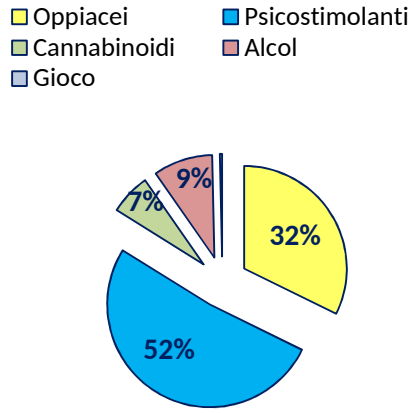
Diversamente dai SerDP territoriali, in carcere si registra una percentuale più alta di pazienti stranieri, con un valore nel 2024 pari a 48%, leggermente calato rispetto al 55% dell'anno precedente. Considerando l'età dei detenuti (media = 37,7), si osserva che l'utenza straniera (media = 34,1) si concentra nelle fasce d'età più giovani, in particolare tra i 18 e i 30 anni e diminuisce gradualmente con l'aumentare dell'età.





Complessivamente, le sostanze d'abuso più diffuse tra gli utenti in carcere appartengono alla classe degli psicostimolanti, che raggiungono il 52% (erano 44% nel 2023). Tra utenti italiani e stranieri non emergono differenze rilevanti nella prevalenza della sostanza primaria.





TABAGISMO

Nel 2024, sono 245 le persone che hanno avuto almeno un accesso presso uno dei due centri antifumo (CAF) della provincia, situati rispettivamente a Parma e Fidenza, un numero in aumento rispetto alle 189 del 2023. L'età media degli utenti è di 55,6 anni, con un valore più elevato per le donne (57,2 contro 54,1 anni), che rappresentano il 49% degli accessi (erano il 41% nell'anno precedente). I cittadini stranieri costituiscono solo il 4,1% degli utenti, in calo rispetto al 7% del 2023.

Centro Antifumo	N	N femmine (%)	N stranieri (%)	Età media (dev. st.)
CAF Fidenza	85	41 (48%)	3 (3,5%)	56.8 (11,6)
CAF Parma	160	80 (50%)	7 (4,4%)	55,0 (11,9)
AUSL	245	121 (49%)	10 (4,1%)	55.6 (11,8)

Classi d'età	N femmine (%)	N maschi (%)
18-29	2 (1,7%)	5 (4,0%)
30-39	5 (4,1%)	15 (12,1%)
40-49	21 (17,4%)	24 (19,4%)
50-59	38 (31,4%)	29 (23,4%)
>59	55 (45,5%)	51 (41,1%)

AMBULATORIO PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE (AMLDP)

L'ambulatorio per gli Accertamenti Medico-Legali dell'area delle Dipendenze Patologiche (AMLDP) rilascia certificazioni medico-legali di non tossicodipendenza o alcoldipendenza, in raccordo con il servizio di Medicina Legale, la commissione patenti, i medici competenti, il servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'AUSL di Parma, la Motorizzazione Civile o su richiesta diretta dell'utente.

Nel 2024 hanno usufruito delle prestazioni 451 persone, in prevalenza uomini (88%), per lo più di età compresa tra i 18 e i 39 anni (57%). I cittadini stranieri sono stati 60 (13,3%). Cinque utenti sono stati inviati

dal medico competente (D.Lgs. 81/2008), mentre i restanti sono stati valutati su richiesta della Commissione Medica Locale per violazioni degli articoli 186 o 187 del codice della strada, oppure per la partecipazione a corsi info-educativi previsti dalla normativa in conseguenza delle suddette violazioni.

Classi d'età	N femmine (%)	N maschi (%)	Totale
18-29	12 (2,7%)	106 (23,5%)	118 (26,2%)
30-39	20 (4,4%)	119 (26,4%)	139 (30,8%)
40-49	9 (2,0%)	83 (18,4%)	92 (20,4%)
50-59	7 (1,6%)	65 (14,4%)	72 (16,0%)
>59	5 (1,1%)	25 (5,5%)	30 (6,7%)

UNITÀ DI STRADA (UDS)

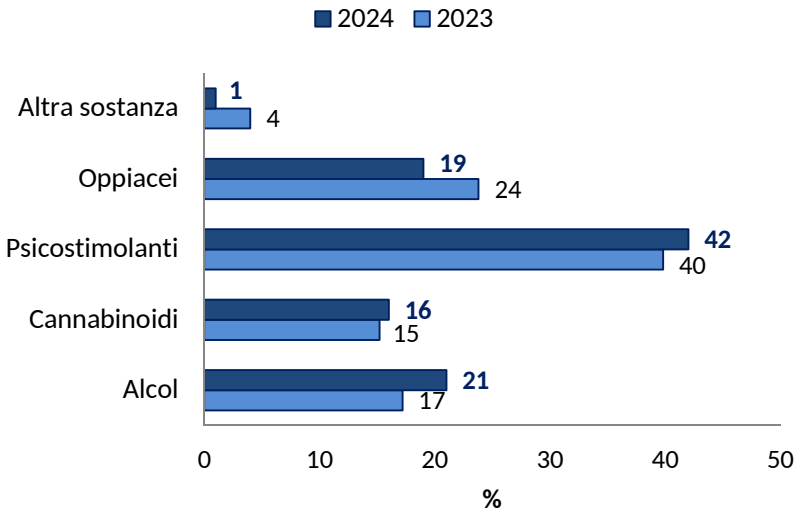
Nel 2024 presso la struttura a bassa soglia di accesso Drop-in, rivolta a consumatori attivi nell'uso di sostanze che effettua interventi di riduzione del danno offrendo materiali di profilassi e servizi, sono stati seguiti 181 soggetti: consumatori di droghe e/o farmaci per il 69%, di alcol per il 16%, il restante 15% è composto da soggetti astinenti e/o da familiari. Il 27% dei soggetti (48 consumatori) hanno acceduto per la prima volta al servizio di UDS, un numero quasi doppio rispetto a quello del 2023.

Di questi, circa la metà non ha mai avuto un trattamento o un accesso presso un SerDP nella vita. Il 90% dei soggetti ha più di 30 anni, il 19% è di genere femminile, una percentuale in aumento e superiore a quella presente negli altri Drop-in della regione ER. Diminuiscono i soggetti seguiti che vivono in strada, mentre aumentano gli stranieri, che per un terzo risultano senza permesso di soggiorno. Il dormitorio a bassa soglia di accesso "La Sosta", gestito in collaborazione con la comunità di servizio e accoglienza Betania, ha aumentato la capacità di capienza da 6 a 7 posti, consentendo una maggiore possibilità di accoglienza per consumatori attivi nell'uso di sostanze sul nostro territorio. Ha ospitato 63 soggetti, è diminuita la percentuale delle donne (13%) mentre risulta in aumento l'accoglienza di soggetti stranieri (46%).

DROP IN	**2022**	**2023**	**2024**
Utenti	194	160	181
Nuovi	25%	17%	27%
Femmine	18%	17%	19%
Vive in strada	41%	44%	39%
Stranieri	29%	26%	32%
di cui senza permesso di soggiorno	31%	32%	28%
DORMITORIO 'LA SOSTA'			
Ospiti	55	59	63
Femmine	15%	22%	13%
Stranieri	33%	29%	46%
INTERVENTI DI STRADA			
Numero interventi	106	115	90
Contatti	1.988	1.904	1.089
INTERVENTI NELLE SCUOLE			
Istituti superiori di II° grado	8	9	9
Studenti *peer* formati dagli operatori	42	108	53
Studenti formati dai *peer*	817	721	824
Insegnanti e genitori formati	5	78	38
RIDUZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DEL DIVERTIMENTO			
Numero interventi	28	45	40
Contatti	1.715	2.226	3.100
di cui con etilometro	639	780	991

I soggetti entrati in contatto con l'UDS attraverso la struttura del Drop-in risultano prevalentemente consumatori di psicostimolanti (42% nel 2024, 40% nel 2023). La sostanza principale utilizzata è il crack (cocaina fumata), con una prevalenza del 39%, in aumento rispetto al 31% del 2023. È invece in

diminuzione l'uso di oppiacei, che passa dal 24% nel 2023 al 19% nel 2024. Va tuttavia sottolineato che questi dati si riferiscono esclusivamente alla sostanza principale consumata, mentre il policonsumo rappresenta la modalità prevalente, con pattern d'uso complessi riscontrati nella maggior parte degli utenti.



Gli interventi di strada riportati in tabella si riferiscono a contesti urbani di consumo di sostanze e a gruppi di aggregazione giovanile con comportamenti a rischio. Tali interventi sono accompagnati dalla distribuzione di materiale di profilassi e prevenzione. A questi si aggiungono le uscite rivolte a persone in condizioni di marginalità e dipendenza, durante le quali nell'ambito della campagna ministeriale per l'eradicazione dell'epatite C sono stati effettuati 75 test HCV su sangue capillare in collaborazione con la cooperativa EMC2.

Il *trend* relativo alla distribuzione di siringhe sterili è in calo da alcuni anni (4.654 siringhe e 760 aghi sterili nel 2024) così come la restituzione di siringhe usate agli operatori (381 nel 2024). Questa diminuzione progressiva conferma una riduzione, seppur non un'eliminazione, dei consumi per via iniettiva. Tale fenomeno, osservato anche a livello regionale, riflette un cambiamento nei modelli di consumo (aumento dell'uso di crack) e una trasformazione nei luoghi di aggregazione dei consumatori. Le attività di riduzione del danno si sono quindi ampliate includendo ulteriori strumenti, come la distribuzione di pipe da crack (316 distribuite nel 2024), mirata alla riduzione del rischio di trasmissione di malattie infettive e alla promozione di pratiche di consumo più sicure, affiancata da attività di consulenza e supporto in strada.

Gli interventi di riduzione del rischio nelle scuole secondarie di secondo grado si attengono alle linee di indirizzo per l'intercettazione precoce nei contesti scolastici (IPCS) e sono coerenti con gli standard europei (EUPC). Viene utilizzata la metodologia della *peer education*, rivolta prioritariamente a studenti dalla classe terza in avanti che, una volta formati, assumono il ruolo di interlocutori significativi e svolgono attività

formative con compagni e insegnanti sul tema del consumo di sostanze legali e illegali, oltre che sull'accesso ai servizi territoriali. Studenti già formati vengono coinvolti nelle nuove attività di formazione, consentendo l'ampliamento del bacino di utenza (nel 2024 sono stati raggiunti 824 studenti).

Gli interventi nel mondo della notte, finalizzati a ridurre i rischi associati all'abuso di alcol e sostanze nei contesti del divertimento, sono stati realizzati in collaborazione con la cooperativa Eidè. Nel 2024 si è registrato un aumento dei contatti 'significativi', che sono passati da 2.226 nel 2023 a 3.100 nel 2024, grazie all'attivazione di postazioni informative, spazi *chill-out*, interventi di primo soccorso e al coordinamento con gli organizzatori degli eventi e gli operatori della sicurezza. Tra questi contatti, 991 (erano 780 nel 2023) sono stati effettuati tramite test dell'alcolemia, strumento utile alla promozione della sicurezza stradale.

PROGRAMMI E PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI (PDTA)

PDTA AUTISMO

Come previsto dal PDTA, per la fascia 0–17 anni, proseguono le convenzioni con la Fondazione Bambini e Autismo, con Kirikù, e con la Fondazione Don Gnocchi (NPIA). Sono inoltre attive collaborazioni con gli istituti scolastici e con i Servizi Sociali dei diversi Comuni, che prevedono l'attivazione di progetti specifici rivolti a singoli casi o a piccoli gruppi.

Nel 2024 si è dato particolare rilievo all'inserimento in percorsi convenzionati dei bambini in età prescolare. Avvalendosi del Fondo Nazionale Inclusione Disabilità a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico (ASD), nei quattro Distretti sono stati attivati interventi integrativi modulati sulle esigenze specifiche dei singoli territori. È stata inoltre avviata una formazione sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), rivolta al personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e primarie del distretto di Parma, che ha suscitato grande partecipazione e ha avuto ricadute positive sull'attività educativa quotidiana.

Presso la Casa del Bambino e dell'Adolescente di Parma è stato attivato un ambulatorio infermieristico, dove gli infermieri del CNPIA eseguono esami ematici per il monitoraggio dei trattamenti farmacologici nei bambini e ragazzi con ASD in carico al servizio. Grazie ai finanziamenti del "Fondo Autismo" (DGR 482 e 481 del 2023), è stato potenziato il personale dedicato alla presa in carico dei pazienti con ASD. Sono state rinnovate per un altro anno le convenzioni con la Fondazione Bambini e Autismo e con Il Cortile (Akela e Kirikù). A fine 2024 è stato pubblicato un avviso rivolto agli ETS per l'attivazione di interventi abilitativi nella fascia 0–6 anni nel distretto di Parma.

Sono aumentati i soggetti affetti da sindrome dello spettro autistico seguiti dai servizi della NPIA che sono passati da 668 nel 2023 a 744 nel 2024.

DISTRETTO	0-6	7-11	12-14	15-17	>18 NPIA	Totale
PARMA	177	173	48	30	12	440
FIDENZA	51	42	16	16	11	136
SUD EST	41	54	12	14	3	124
VALLI TARO E CENO	10	12	10	6	6	44
TOTALE	279	281	86	66	32	744

I soggetti adulti in carico presso i Centri di Salute Mentale nel 2024 sono stati 92 (erano 104 nel 2023), la cui distribuzione per fasce d'età è mostrata nella tabella sottostante.

DISTRETTO	18-25	26-35	>35	Totale
PARMA	31	24	7	62
FIDENZA	13	3	3	19
SUD EST	3	0	0	3
VALLI TARO E CENO	5	2	1	8
TOTALE	52	29	11	92

Per i giovani adulti sono stati realizzati interventi di gruppo finalizzati al potenziamento delle competenze sociali (*social skills*), dell'autoconsapevolezza, dell'affettività e sessualità, con uno spazio dedicato al tema dell'identità femminile nelle donne con ASD. In parallelo, sono state attivate iniziative di parent-supporting rivolte ai genitori.

È proseguita l'attività dell'équipe mobile sperimentale, che nel 2024 ha offerto consulenza su 5 casi di ASD di livello 3, con gravi comportamenti problematici, inseriti in centri socio riabilitativi residenziali e diurni.

È inoltre iniziata la collaborazione con il progetto "Lavorare in Rete", promosso da ANFFAS Parma, finalizzato all'accompagnamento e all'inserimento nel mondo del lavoro.

Nel corso dell'anno sono stati approvati e finanziati due progetti su fondi privati e di fondazioni, sviluppati con il Comune di Parma e il terzo settore:

- Progetto D.A.M.A., per la formazione del personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e dell'AUSL,
- "Alleanza per i caregiver" e "Sostenere i caregiver", progetti di sistema che intendono mettere in rete gli interventi a favore dei caregiver, affiancando azioni strutturali e progetti individualizzati.

PERCORSO TUTELA MINORI

I casi che richiedono interventi di collaborazione socio-sanitaria per minori in ipotesi di pregiudizio (maltrattamento, abuso, trascuratezza, violenza assistita e coinvolgimento in gravi separazioni conflittuali) sono passate da 239 nel 2023 a 347 nel 2014 (+45%). Le principali categorie di segnalazione riguardano separazioni altamente conflittuali (30%), situazioni di violenza assistita (25%) e casi di maltrattamento diretto nei confronti del minore (15%). Dal punto di vista della provenienza, la nazionalità prevalente è quella italiana, seguita da minori originari dell'Africa subsahariana e del Maghreb. Le implicazioni diagnostiche riscontrate nei percorsi di tutela si riferiscono prevalentemente a esiti di sviluppo traumatico, con manifestazioni cliniche eterogenee nell'ambito della condotta e/o della sfera emotiva, con sintomatologia sia di tipo internalizzante sia esternalizzante.. A partire da medesime esperienze sfavorevoli infantili, l'incidenza dei fattori socio-culturali e di quelli protettivi di resilienza individuale e famigliare, hanno un forte impatto sulle differenti traiettorie evolutive del bambino in senso più o meno psicopatologico. Nel 2024, i percorsi per la tutela minori (ex DGR 1102/2014), che riguardano i ragazzi in collocazione extrafamiliare, hanno registrato una sostanziale stabilità dei casi seguiti.

	Parma	Fidenza	Sud Est	VTC	Totale
A dicembre **2021**	57	8	7	3	75
A dicembre **2022**	50	5	9	1	65
A dicembre **2023**	51	9	6	2	68
A dicembre **2024**	47	5	7	6	65

ESORDI PSICOTICI

Il numero di pazienti trattati nell'ambito del PDTA Esordi Psicotici si conferma stabile rispetto all'anno precedente (193 casi nel 2024 contro 195 nel 2023), pur evidenziando variazioni significative nell'uso di sostanze (da 39 a 52 casi) e nella fascia d'età 12-24 anni, che registra un forte aumento (da 47 a 102 pazienti nel 2024).

Per rispondere ai bisogni emergenti nella fascia 12-25 anni, nel 2024 sono stati attivati percorsi formativi specifici rivolti ai professionisti delle diverse aree coinvolte (cure primarie, psicologia clinica, servizi sociali), insieme a gruppi di intervisione per il confronto e l'armonizzazione degli interventi previsti dal PDTA-EP, in particolare nel percorso "B" per i soggetti a rischio di psicosi.

Sono proseguite le attività di ricerca: è stato completato un primo lavoro di valutazione d'esito sui soggetti a rischio, che richiederà un ampliamento della casistica e la costituzione di un network regionale e nazionale. È stato inoltre condotto uno studio sull'impatto della formazione attiva sugli operatori del programma Esordi Psicotici a livello regionale.

Infine, sono stati attivati interventi congiunti SerDP/NPIA/SMA per garantire una presa in carico più adeguata, alla luce del crescente numero di adolescenti e giovani adulti con EP associata all'uso di sostanze.

Esordi Psicotici	2021	2022	2023	2024
Pazienti in percorso PDTA Esordi Psicotici	167	192	195	193
Psicosi non trattate (mesi)	8,3	9,0	9,5	9,0
Uso di sostanze nei nuovi casi	29	36	39	52
Età compresa tra 15 e 24 anni	52	50	47	102
Percorso B (segmento 12-25 anni)	30	39	44	58

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE (DNA)

Nel 2024 si è confermata l'elevata incidenza di nuovi casi di disturbi dell'alimentazione e della nutrizione (DNA), con una prevalenza di forme gravi di anoressia, in continuità con quanto osservato nel 2021 e nel 2022. I nuovi casi registrati nel 2024 (n=132) risultano infatti sovrapponibili a quelli del 2023.

Si conferma inoltre una maggiore incidenza nella fascia di età adulta (totale 77) rispetto a quella minorile (totale 55), in linea con il trend già rilevato l'anno precedente. Il numero complessivo di utenti in carico nel corso del 2024 si mantiene elevato (totale 389, di cui 299 maggiorenni), pur risultando lievemente inferiore rispetto al 2023, a seguito di diverse dimissioni per remissione completa avvenute nel 2023 (totale 76) e nel 2024 (totale 32).

Diagnosi (cod. ICD X)	Classi d'età				Totale
	<12	12-17	18-35	>35	
Anoressia nervosa (F50.0)	0	37	105	16	158
Anoressia nervosa atipica (F50.1)	0	18	23	3	44
Bulimia nervosa (F50.2)	0	5	48	9	62
Bulimia nervosa atipica (F50.3)	0	0	1	1	2
Iperalimentazione associata ad altri dist. psicologici (F50.4)	0	1	1	1	3
Vomito associato con altri disturbi psicologici (F50.5)	0	0	1	0	1
Altri disturbi dell'alimentazione (F50.8)	2	4	18	3	27
Disturbo dell'alimentazione non specificato (F50.9)	1	22	59	10	92
Totale	**3**	**87**	**256**	**43**	**389**

DISTURBI GRAVI DI PERSONALITÀ (DGP)

Il PDTA dedicato al Disturbo Borderline di Personalità (DBP) rappresenta un'evoluzione del precedente Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per i Disturbi Gravi di Personalità (DGP). Tale revisione è stata effettuata in coerenza con le recenti linee di indirizzo regionali, che individuano con maggiore precisione il focus delle raccomandazioni clinico-assistenziali nel nucleo psicopatologico specifico del Disturbo Borderline. L'obiettivo del nuovo PDTA è quello di garantire una presa in carico più mirata e personalizzata, basata sulle evidenze e sui bisogni peculiari di questi pazienti, promuovendo un approccio integrato tra servizi territoriali, strutture residenziali e specialisti, in un'ottica di continuità terapeutica e riabilitativa.

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il Disturbo Borderline di Personalità (PDTA DBP) è rivolto agli utenti già in carico ai servizi del DAI-SMDP, residenti o domiciliati sul territorio provinciale. Costituisce criterio di inclusione la diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità. In coerenza con le più recenti evidenze scientifiche, per l'area dell'età evolutiva, rientrano nel percorso anche i quadri pre-sintomatici o pre-clinici, se interpretati come potenzialmente prodromici di un Disturbo di Personalità da parte del professionista che effettua la diagnosi. In particolare, per la fascia di età compresa tra i 14 e i 40 anni, viene previsto un percorso maggiormente strutturato e intensivo, pensato per rispondere in modo più efficace alle specifiche esigenze evolutive, relazionali e psicopatologiche di questa popolazione.

Nel corso del 2024, i pazienti con una diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità presi in carico dai Servizi del DAI-SMDP sono stati complessivamente 318, di cui 184 rientrano nella fascia di età tra i 14 e i 40 anni, target privilegiato del PDTA per la strutturazione di un intervento più specifico e intensivo.

Sesso	N	%	Età Media	Deviazione std.
Femmina	249	78,3	35,93	15,88
Maschio	69	21,7	44,86	15,79
Totale	318	100,0	37,87	16,26

Il percorso di cura per il DBP, così come delineato nel PDTA, si configura come un trattamento psicosociale strutturato in fasi distinte, sottoposte a monitoraggio tramite indicatori di processo ed esito. L'approccio adottato è di tipo pragmatico, centrato sui fattori comuni delle terapie *evidence based*, al fine di garantire coerenza metodologica e flessibilità clinica.

Elemento centrale del trattamento è la formulazione condivisa di un contratto di cura, che rappresenta il patto terapeutico tra il paziente e l'équipe multidisciplinare. Il percorso si fonda sull'integrazione sinergica di diverse professionalità, che operano in modo coordinato per sostenere, attraverso la relazione terapeutica, la motivazione al cambiamento e l'adesione al trattamento. Inoltre, una componente qualificante del percorso è rappresentata dai gruppi psicoeducativi di skills training, realizzati in coerenza con il modello terapeutico DBT-*oriented* (Dialectical Behavior Therapy). Tali gruppi sono orientati all'acquisizione di competenze per la gestione delle emozioni, la riduzione dei comportamenti disfunzionali, il potenziamento delle capacità di *problem solving* e lo sviluppo di strategie adattive per affrontare gli eventi di vita quotidiana. Nel corso del 2024 sono stati attivati 5 gruppi a cura dei SerDP e 4 gruppi da parte dei servizi di Salute Mentale Adulti, coinvolgendo complessivamente 105 persone.

Gruppi di Skills Training attivi nel 2024

Servizio	Tipologia gruppo (N partecipanti)	Età media/ Fascia d'età
Dipendenze Patologiche	1) Skills Training DBT (8) 2) Skills Multifamiliare DBT Adolescenti (20) 3) Skills Training DBT (8) 4) Skills Training DBT (10) 5) Skills Training DBT (5)	1) 35-50 2) 17-25 3) ~40 4) ~50 5) 26-40
Salute Mentale Adulti	1) Skills Training DBT (15) 2) Skills Training DBT (15) 3) Skills Training DBT (12) 4) Skills Training DBT (10)	1) 19-30 2) 19-30 3) 19-30 4) 18-40

PERCORSI GIUDIZIARI

Per quanto riguarda l'area delle Dipendenze Patologiche, 20 pazienti, pari al 17% dei 115 complessivamente inseriti in trattamenti residenziali (comunità terapeutiche), vi sono stati ammessi a seguito di provvedimenti giudiziari.

La misura di sicurezza non detentiva viene attuata nel 36% dei casi al domicilio del paziente, con il supporto di cure ambulatoriali erogate dal CSM. Il restante 64% dei pazienti è accolto presso strutture residenziali sanitarie e socio-residenziali del DAISM-DP, in particolare nella residenza Giovani Adulti.

Grazie a queste forme di accoglienza, nel corso del 2024, il numero di pazienti in carico presso la REMS si è ridotto da 5 a 1.

BUDGET DI SALUTE (BdS)

Nel 2024 sono proseguiti i progetti nazionali e regionali per l'applicazione del Budget di Salute (BdS), che vedono l'AUSL di Parma partner della Regione Emilia-Romagna e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nello stesso anno è stata completata la prima fase del progetto di Visiting denominato "Audit qualitativo presso strutture residenziali sanitarie RTE e sociosanitarie".

Si è concluso il percorso di coprogettazione, che ha previsto l'ampliamento dei servizi innovativi, tra cui i servizi di comunità e prossimità, e ha portato all'attivazione di un progetto di cohousing nel territorio di Fornovo e di due progetti di recovery house nel territorio di Parma.

Nel mese di giugno 2024 è stato completato il progetto di Visiting (avviato nel 2023), sempre denominato "Audit qualitativo presso strutture residenziali sanitarie RTE e sociosanitarie" a gestione esternalizzata, in conformità con una procedura interna specifica elaborata dal DAISM-DP. Tale progetto è inserito in un'iniziativa più ampia denominata "Miglioramento Residenzialità e Recovery". In totale, sono state visitate 16 strutture residenziali di varia tipologia, tra cui RTE, gruppi appartamento, comunità alloggio e alloggi con Budget di Salute.

Prosegue inoltre il potenziamento dei servizi di comunità e prossimità, già citati, che includono il cohousing di Fornovo e le due recovery house di Parma.

Sia le attività di Visiting svolte, sia gli incontri semestrali programmati tra il cruscotto direzionale e ciascun CSM, hanno consentito un monitoraggio più accurato della qualità e dell'adeguatezza dei percorsi riabilitativi residenziali, contribuendo all'incremento del tasso di turnover.

Per quanto riguarda i progetti BdS, nel corso del 2024 ne risultano attivi 297, così suddivisi:

- 152 progetti in cogestione con cooperative sociali;
- 77 progetti di tipo "Recovery", centrati sulla domiciliarità, attivati presso alloggi secondo la metodologia BdS, di cui: 38 realizzati attraverso appartamenti in uso al DAISM-DP; 37 in cogestione con cooperative sociali; 68 progetti BdS attivati sull'asse formazione-lavoro, sotto forma di tirocini AUSL.

Distretto	Progetti in cogestione	Alloggi temp. Recovery	Alloggi con BdS	Formazione/ Lavoro	Totale
Parma	89	38	4	38	169
Fidenza	18	0	17	23	58
Sud Est	29	2	0	4	35
Valli Taro e Ceno	16	0	16	3	35
Totale	**152**	**40**	**37**	**68**	**297**

Il DAISM-DP coordina il tavolo regionale per il Budget di Salute e partecipa attivamente al progetto nazionale guidato dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

In questa sede sono rendicontati tutti i progetti BdS attivati nel 2024, compresi i percorsi di formazione e lavoro, identificati come Progetti Recovery. Questi comprendono: tirocini AUSL a carattere socializzante, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione; percorsi individualizzati IPS; progetti BdS sviluppati a partire dall'area "abitare", come gli Alloggi temporanei per la recovery e gli Alloggi con BdS.

Il dato appare in lieve aumento rispetto al 2023 (il totale era di 279) con alcune variazioni più significative sul distretto di Fidenza (che passa da 35 a 58).

Gli incontri con il Comitato Utenti Familiari (CUF)

Nel corso dei tre incontri tenutisi nel 2024, sono state gettate le basi per l'avvio di un progetto di coprogettazione delle attività dipartimentali, che mira a coinvolgere attivamente operatori, utenti e familiari nella definizione condivisa delle azioni di cura e riabilitazione. In tale contesto, sono state presentate anche le principali iniziative del Recovery College, con l'obiettivo di promuovere un approccio orientato al recupero e alla partecipazione.

Parallelamente, è proseguita l'attività di *visiting* presso le strutture residenziali private. Questi sopralluoghi, condotti da équipe multidisciplinari, hanno avuto lo scopo di verificare il rispetto dei criteri di sicurezza e la qualità dell'offerta riabilitativa, con particolare attenzione alla coerenza delle attività con i progetti terapeutici individualizzati.

Iniziative formative e comunicazione sociale nell'ambito del progetto "Rete per la Recovery".

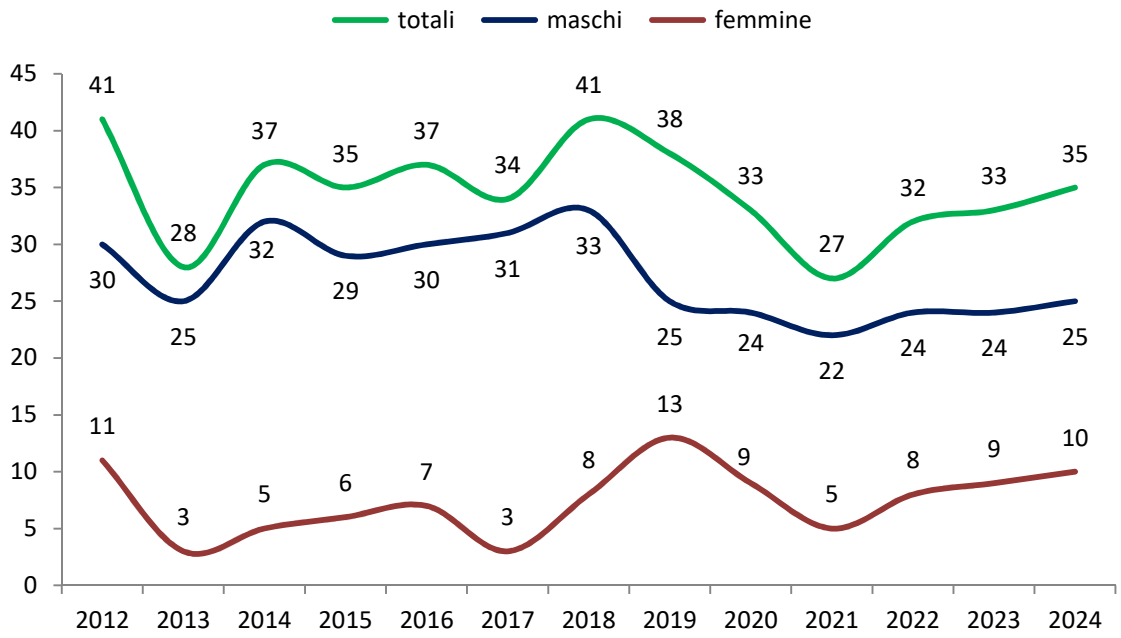
Nel quadro delle attività di formazione e promozione della cultura della salute mentale, sempre nell'ambito del progetto "Rete per la Recovery", sono stati realizzati tre importanti seminari pubblici, che hanno riscosso ampio interesse e partecipazione:

- 14 marzo: seminario "Franco Basaglia: un profilo", a cura del direttore del Dipartimento, Pietro Pellegrini. Tra gli ospiti, Paolo Peloso, psichiatra e studioso del pensiero basagliano, ha offerto un prezioso contributo di approfondimento storico e teorico.
- 18 aprile: seminario "Liberi Tutti", organizzato in ricordo di Franco Basaglia, a cura di Giuseppina Paulillo, responsabile della UOC Residenzialità Psichiatrica e Psicologia Forense – DAISM DP AUSL Parma. Tra gli interventi, si segnala la partecipazione di Valeria Paola Babini, storica della psichiatria e tra le massime studiose del movimento di riforma italiano.
- 9 maggio: seminario "L'arte di legare le persone", ancora a cura di Giuseppina Paulillo, con l'intervento dello psichiatra e scrittore Paolo Milone, autore di riflessioni significative sull'esperienza del lavoro in SPDC.

Appendice

Abbiamo ritenuto opportuno riportare, alla fine del report, alcuni dati forniti dal Dipartimento di Sanità Pubblica relativi a un fenomeno particolarmente rilevante e complesso: il suicidio. Si tratta di un fenomeno correlato a un'ampia gamma di fattori biologici, psicologici, relazionali, sociali, economici, culturali e religiosi, e non può essere considerato esclusivamente come espressione di disturbi mentali.

I dati presentati illustrano l'entità del fenomeno e la sua evoluzione nel periodo 2012-2024, con l'obiettivo di stimolare una riflessione che coinvolga tanto i singoli quanto l'intera comunità. Dopo alcuni anni di progressiva riduzione, negli ultimi tre anni si è registrato un lieve aumento dei casi di suicidio. Nel 2024, nel territorio di Parma, si sono verificati 35 suicidi, con una netta prevalenza di soggetti di sesso maschile (25 casi).



Considerando i pazienti seguiti dal DAISM-DP, nel 2024 si osserva una diminuzione dei decessi per suicidio (4), in linea con la media degli ultimi dieci anni (3,5) nel periodo storico analizzato.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Utenti DAI-SMDP	9	4	4	2	2	5	4	2	4	2	3	7	**4**

NOTE CONCLUSIVE

Il Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche è dotato di una rete molto ampia costituita da 42 punti ambulatoriali (12 della NPIA, 20 della PA e 10 delle DP), 22 Residenze (1 per la NPIA, 18 per la PA e 3 per le DP), i Servizi Psichiatrici Ospedalieri a direzione universitaria, l'Ospedale Privato "Maria Luigia" e le collaborazioni con Enti del Terzo Settore e Fondazioni, volontariato e Comitato Utenti Familiari.[1] Un servizio profondamente radicato nel territorio che opera in tutte le Case della Comunità e segue quasi il 97% delle persone a domicilio.

Nel 2024 hanno avuto almeno un accesso quasi 18 mila persone con un incremento del 3,2% rispetto al 2023. Ciò ha comportato un aumento del carico operativo che è testimoniato dalla crescita delle consulenze in PS ed un aumento dei ricoveri ospedalieri.

Una maggiore pressione si è avuta anche nei servizi territoriali che hanno fatto importanti sforzi per strutturare e realizzare al meglio i diversi PDTA (esordi psicotici, disturbi del comportamento alimentare, disturbi dello spettro autistico, disturbo borderline di personalità, multicomplessità) e assicurare la migliore terapia anche nei contesti difficili come gli Istituti di pena e i servizi per i migranti, i senza tetto. Sono state messe in atto azioni come il *visiting* per migliorare la qualità delle cure e si è operato per favorire il turnover nella rete residenziale e fare della casa il primo luogo di cura e di vita anche mediante l'utilizzo di strumenti nuovi quali il budget di salute, la coprogettazione e l'innovazione dei servizi di comunità, l'unità di strada, il centro diurno diffuso, le équipe mobili.

Grande è l'impegno della NPIA per dare risposte alle persone con autismo e alle loro famiglie, ai ragazzi e ai giovani con disturbi internalizzanti ed esternalizzanti, uso di sostanze, tentati suicidi e autolesività, in contesti che fanno fatica e nei quali sembrano evidenti le crisi familiari, educative e sociali.

L'uso di sostanze si è spostato verso la cocaina, gli stimolanti e le nuove sostanze psicoattive pur permanendo importante l'uso di eroina, alcool e tabacco. Vi sono segnali preoccupanti circa il gioco patologico e nuove forme di dipendenza da internet, cellulari con forti ricadute in ambito familiare, scolastico e sociale. Vi è una sofferenza che appare ma molta è sommersa. Su questi aspetti il DAI-SMDP si sta attrezzando per adottare le più aggiornate modalità di intervento e nell'ambito del Patto Sociale per Parma dare vita al Percorso Crescita (fascia 0-6 anni) e ad azioni preventive.

Il 2024 ha evidenziato come la sofferenza mentale, prevista nella fase del Covid, si stia manifestando nel post-pandemia, che si configura come una fase sindemica con diverse crisi concomitanti, sociale, economica, ambientale e della pace. La povertà, le diseguaglianze, le migrazioni, internet, la globalizzazione e il cambiamento climatico stanno segnando un passaggio epocale per le persone e la stessa vita sul pianeta. I dati sui suicidi devono indurre una riflessione sulla sofferenza sommersa, sulla qualità di vita e sulla speranza.

[1] https://www.ausl.pr.it/azienda/daismdp/default.aspx

Nel corso del 2025 vedremo se l'indubbio aumento della domanda ai servizi per la salute mentale verificatosi lo scorso anno, avrà carattere transitorio o di lunga durata e ciò potrà dipendere dalla capacità o meno di ricostituire i legami sociali e le prospettive di futuro. Vi è da augurarsi che l'andamento sociale possa portare ad una rinnovata configurazione del patto sociale solidale e del sistema di comunità pubblico e universale entro il quale opera il DAI-SMDP in grado di evitare sia le forme di neoistituzionalizzazione sia ogni deriva abbandonica. Infine voglio ringraziare tutti gli operatori che con impegno, motivazione e competenza ed etica si dedicano alle persone che soffrono e alle loro famiglie cui va il mio pensiero nella convinzione che siano la prima e fondamentale risorsa per una cultura della cura.

Direttore del Dipartimento

Pietro Pellegrini

Il presente report è stato redatto da

Barbara Cantarelli e Leonardo Tadonio

(Osservatorio sulle Dipendenze)

Stefano Giovanelli

(Sistema Informativo DAISMDP)